

สมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด

(Competency Development for Perioperative Nurses)



พว.ธนพรรณ กุณาละสิริ
หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ งานการพยาบาลผ่าตัด
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

Competency

- ความหมาย
- ประโยชน์ ความจำเป็น
- ประเภทของ Competency
- ขั้นตอน วิธีการ ประเมิน
- ตัวอย่างการประเมิน Competency



Competency

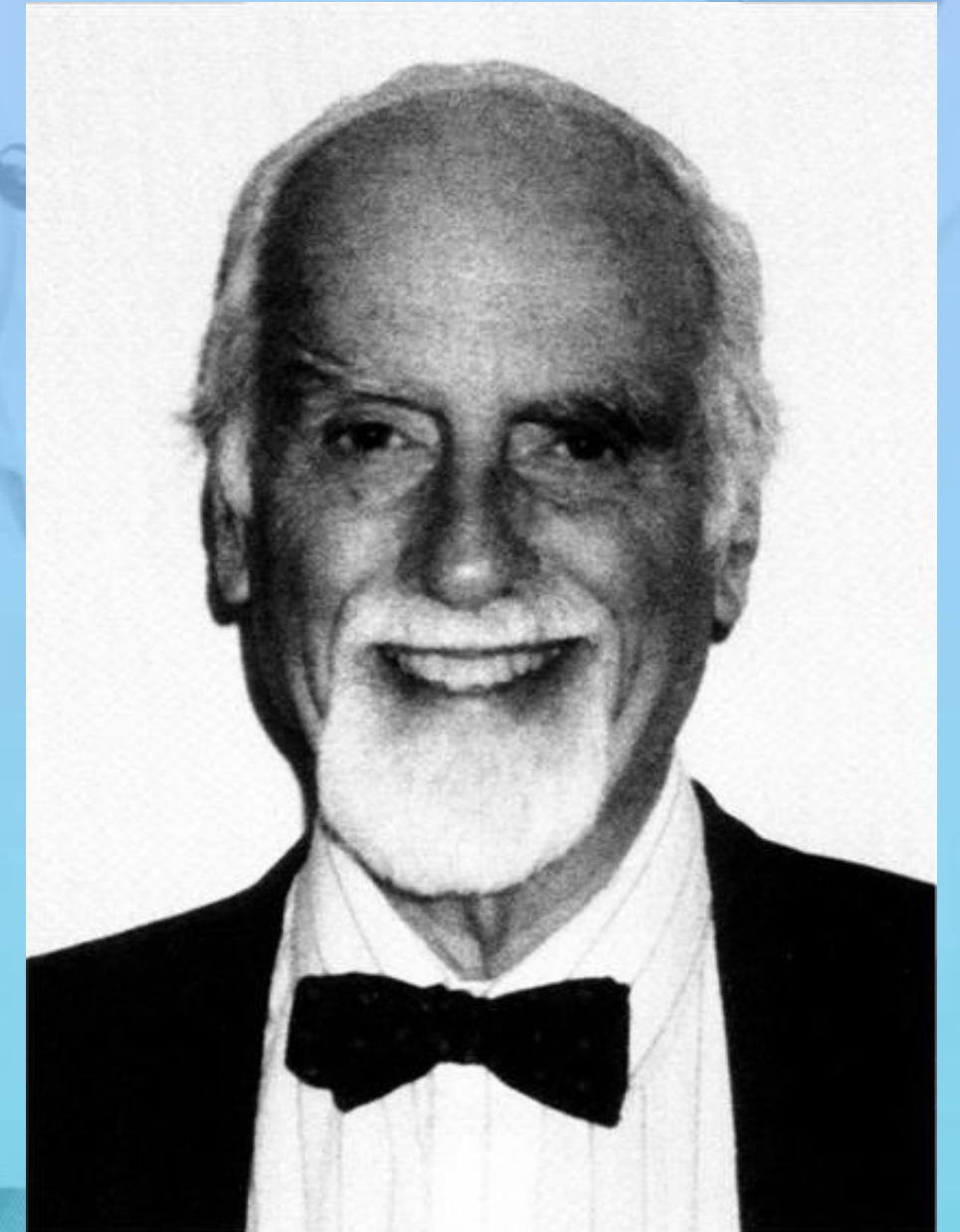
- แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทำงาน (Competency) เกิดขึ้นในช่วง ปี 1970
- David Mc Clelland ศึกษาวิจัยว่าเหตุใดบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานแตกต่างกัน

David Clarence McClelland

(May 20, 1917 – March 27, 1998)

American psychologist

Human Achievement and Motivation Research

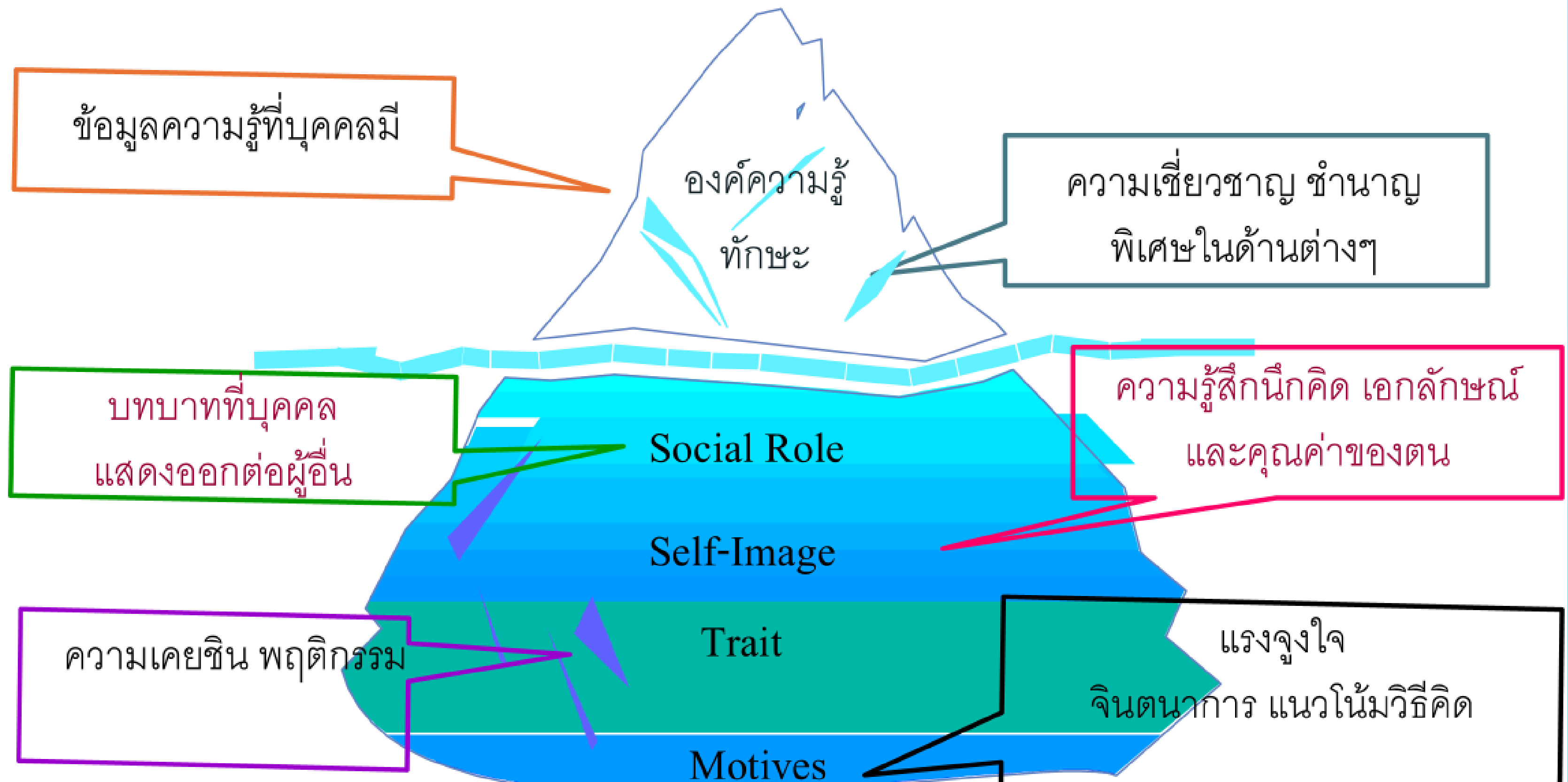


**สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ละ
บุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่ตน
รับผิดชอบ**

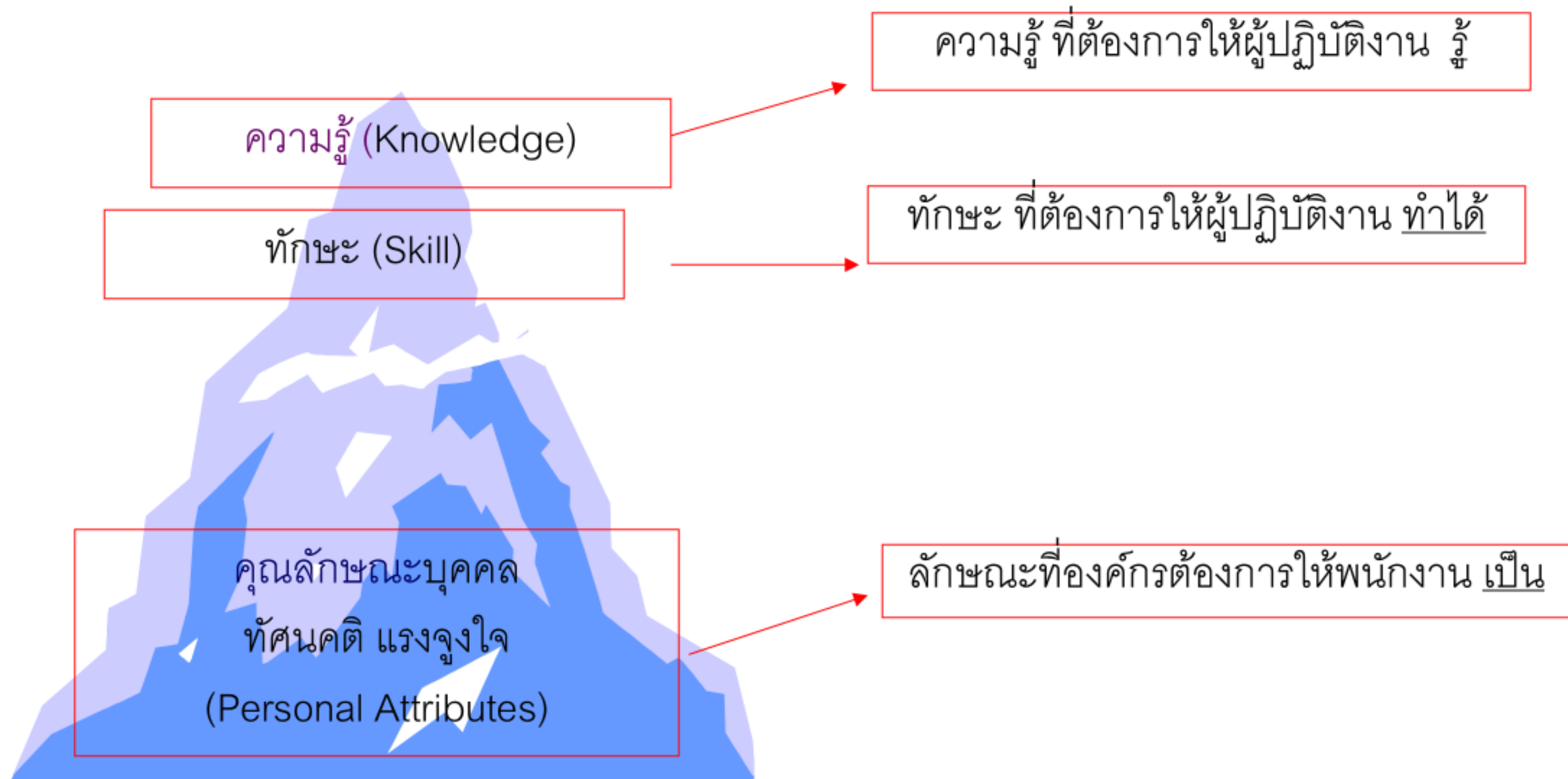


(David Mc Clelland)

แนวคิด The Iceberg Model



แนวคิด The Iceberg Model



Reference : David C. McClelland - Lyle M. Spencer , Jr.

Competency



- คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและความคิดที่เป็นไปในสถานการณ์อย่างต่อเนืองหรือเป็นไปอย่างเป็นประจำเป็นเวลานาน
- Competency มีความสำคัญเชื่อมโยงอย่างมากกับผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม



สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่จำเป็น
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ประกอบขึ้นจากทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล
หรือพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม



(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ,2553)

สมรรถนะหลัก หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือนประกอบด้วย

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรรยาบรรณ
5. การทำงานเป็นทีม

**คู่มือการกำหนดสมรรถนะในข้าราชการพลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก
เผยแพร่ พ.ศ. 2553**

สภาการพยาบาล



ประกาศสภาการพยาบาล

เรื่อง สมรรถนะหลักของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรและได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลศาสตร์

ตามที่สภาการพยาบาลได้กำหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใช้เป็น
สมรรถนะกลางในการพัฒนาและใช้ศักยภาพของพยาบาล ประกอบกับมาตรา ๗ (๒) และมาตรา ๘ (๕) (๖)
และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และ
อำนาจหน้าที่ให้สภาการพยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาและใช้
ศักยภาพของพยาบาลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงเห็นควรกำหนดสมรรถนะหลักของ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรฝึกอบรมการ
พยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรและได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ และการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลศาสตร์ขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) และมาตรา ๒๓ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สภาการพยาบาลจึงออกประกาศสภาการพยาบาลเรื่อง
สมรรถนะหลักของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร
ฝึกอบรมการพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรและได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลศาสตร์ ตามรายละเอียดที่
กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทีศนา บุญทอง)

นายกสภาการพยาบาล

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

สมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด Perioperative Nurse Competencies

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2554

ISBN 978-974-350-657-4

สมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด Perioperative Nurse Competencies

พยาบาลห้องผ่าตัด (Perioperative Nurse) เป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ดูแลผู้ป่วยที่มา รับการผ่าตัด หรือหัตถการอื่นๆในห้องผ่าตัด ทั้งระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด โดยใช้ กระบวนการพยาบาลในการประเมิน วินิจฉัย วางแผน ปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผลลัพธ์ การปฏิบัติการพยาบาล ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมทั้งใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนั้นพยาบาลห้องผ่าตัดจึงต้องมีสมรรถนะ ที่เพียงพอและสอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว

สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถ (Ability) ในการกระทำการใดๆ ที่อยู่ใน ระดับที่เป็นที่ยอมรับ (Cambridge International Dictionary, 1995) JCAHO (1993 อ้างใน Gruendemann and Fernsebnee, 1995) ให้ความหมายของสมรรถนะพยาบาลว่า คือ ความสามารถของพยาบาล ในการปฏิบัติงาน โดยมีทักษะและลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นเพียงพอสำหรับตำแหน่งหน้าที่ของ งาน หรือการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย โดยนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ พฤติกรรมมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ส่วน AORN (AORN, 1999) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ (Competency) ว่าหมายถึง ความรู้ ทักษะ และความ สามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในห้องผ่าตัด

ประเภทของสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (จิรประภา อัครบวร, 2549) ได้แก่

1. สมรรถนะหลัก (Core competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์กรต้องมี เพื่อ แสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์กร
2. สมรรถนะตามสายงาน (Functional competency) คือ คุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบัติ งานในตำแหน่งต่างๆ ควรมีเพื่อให้งานสำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ดังนั้นสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด จึงหมายถึง ความสามารถของพยาบาลห้อง ผ่าตัดในการนำความรู้ และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยตามขอบเขตของบทบาทหน้าที่ รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆตามกำหนดในตำแหน่งงาน

คณะกรรมการจัดทำสมรรถนะสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ได้พิจารณา และมีความเห็นว่า สมรรถนะหลักเป็นความสามารถของพยาบาลที่ทุกคนพึงมี ซึ่งกำหนดโดย



สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย(พ.ศ. 2554)

กำหนดสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด 4 ด้าน



- 1.สมรรถนะการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย
- 2.สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยด้านร่างกาย
- 3.สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยด้านการตอบสนองพฤติกรรม
- 4.สมรรถนะพยาบาลด้านระบบสุขภาพ

สมรรถนะการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย

- การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากการเคมี
- การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากเครื่องจี้ไฟฟ้า
- การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากรังสี
- การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากการเคลื่อนย้าย
- การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากการจัดทำ



สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยด้านร่างกาย

- การป้องกันการติดเชื้อ
- การดูแลการทำซ้ำของเนื้อเยื่อ
- การดูแลอุณหภูมิกาย
- การดูแลภาวะสมดุลของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และกรดด่าง
- การดูแลการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด
- การจัดการความปวด



สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยด้านการตอบสนองพฤติกรรม

- การให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ
- ด้านจริยธรรมและการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย



สมรรถนะการพยาบาลด้านระบบสุขภาพ



- ความเป็นวิชาชีพ
- การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานของหน่วยงาน
- การสนับสนุนเป้าหมายองค์กร



Competency



- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การสรรหาและคัดเลือก
- การพัฒนาฝึกอบรม
- การเลื่อนระดับปรับตำแหน่งงาน
- การวางแผนทรัพยากรบุคคล
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การบริหารค่าตอบแทน



การสรรหาและคัดเลือก

- คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานถูกต้องและเหมาะสม
- ลดเวลา ค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน
- ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรใหม่



การเลื่อนระดับปรับตำแหน่งงาน

- พิจารณาการปรับตำแหน่งของบุคลากรให้สูงขึ้น
- ป้องกันความผิดพลาดในการเลื่อนระดับหรือปรับตำแหน่ง พิจารณา Technical Competencies และ Managerial Competencies

การพัฒนาและฝึกอบรม

- ใช้กำหนด Training Road Map
- หา Training Need ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งและความสามารถจริงของบุคคล และนำไปสู่การกำหนด Individual Development Plan
- ช่วยในการจัดทำ Career Development

การวางแผนทรัพยากรบุคคล

- วางแผนกำหนดอัตราหรือจำนวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับปริมาณงาน หรือลักษณะงาน
- ช่วยในการวางแผนการจัดทำ Job Rotation
- ช่วยในการจัดทำ Succession Plan



การประเมินผลการปฏิบัติงาน



- การประเมินผลการปฏิบัติงานสัมพันธ์กับความสำคัญขององค์กร โดยความเชื่อมโยงของ Competency, Strategy, Goals, Mission และ Vision
- ทราบว่า Competency เรื่องใดที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
- ใช้ในการจัดทำ Individual Development Plan

การบริหารค่าตอบแทน

- กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ
- ระบบค่าตอบแทนที่เพิ่มตาม Competency ที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การประเมิน Competency



การเทียบเคียงความสามารถของผู้ถูกประเมิน ตาม
ตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ



การกำหนด Competency IIUU Top down



ປະໂຫຍດ Competency



- **Core Competency**
- **Technical Competency**
- **Non -Technical Competency**



Core Competency หรือ สมรรถนะหลักขององค์กร

- คุณสมบัติที่บุคลากรทุกคนที่ต้องมี เพื่อให้บรรลุความสำเร็จขององค์กร เช่น ความรอบรู้เกี่ยวกับองค์กร ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
- พฤติกรรมของพยาบาลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย



Core Competency

❖ **ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์**

❖ **การคิดเชิงวิเคราะห์**



Technical Competency



- **Competency** ที่กำหนดสำหรับงานในแต่ละด้านหรือตามลักษณะงานซึ่งมีขั้นตอนความสามารถแตกต่างกันไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- **Competency** สะท้อนถึงความลึกซึ้งของความสามารถที่บุคลากรต้องมี ในการได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่



Technical Competency

เป็นระดับความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นพื้นฐานในการประเมินและวางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผลการพยาบาล

- **การให้เลือด**
- **การป้องกันการติดเชื้อ**
- **การจัดการความเจ็บปวด**
- **การประเมินด้านร่างกาย**
- **การสอนผู้ป่วยและครอบครัว**

Technical Competency



สมรรถนะเฉพาะ

•เป็นระดับสมรรถนะ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแล
กลุ่มผู้ป่วย แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะของโรค หรือ
กลุ่มอาการที่คล้ายกัน เช่น ด้านอายุรกรรม
ด้านศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ห้างผ่าตัด

แผนกที่ปฏิบัติงาน	รายการข้อสมรรถนะ
การพยาบาลอายุรกรรม	การพยาบาลผู้ป่วยใช้ เครื่องช่วยหายใจ
การพยาบาลศัลยกรรม	การดูแลแผลผ่าตัด
การพยาบาลห้องผ่าตัด	การป้องกันการติดเชื้อ
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

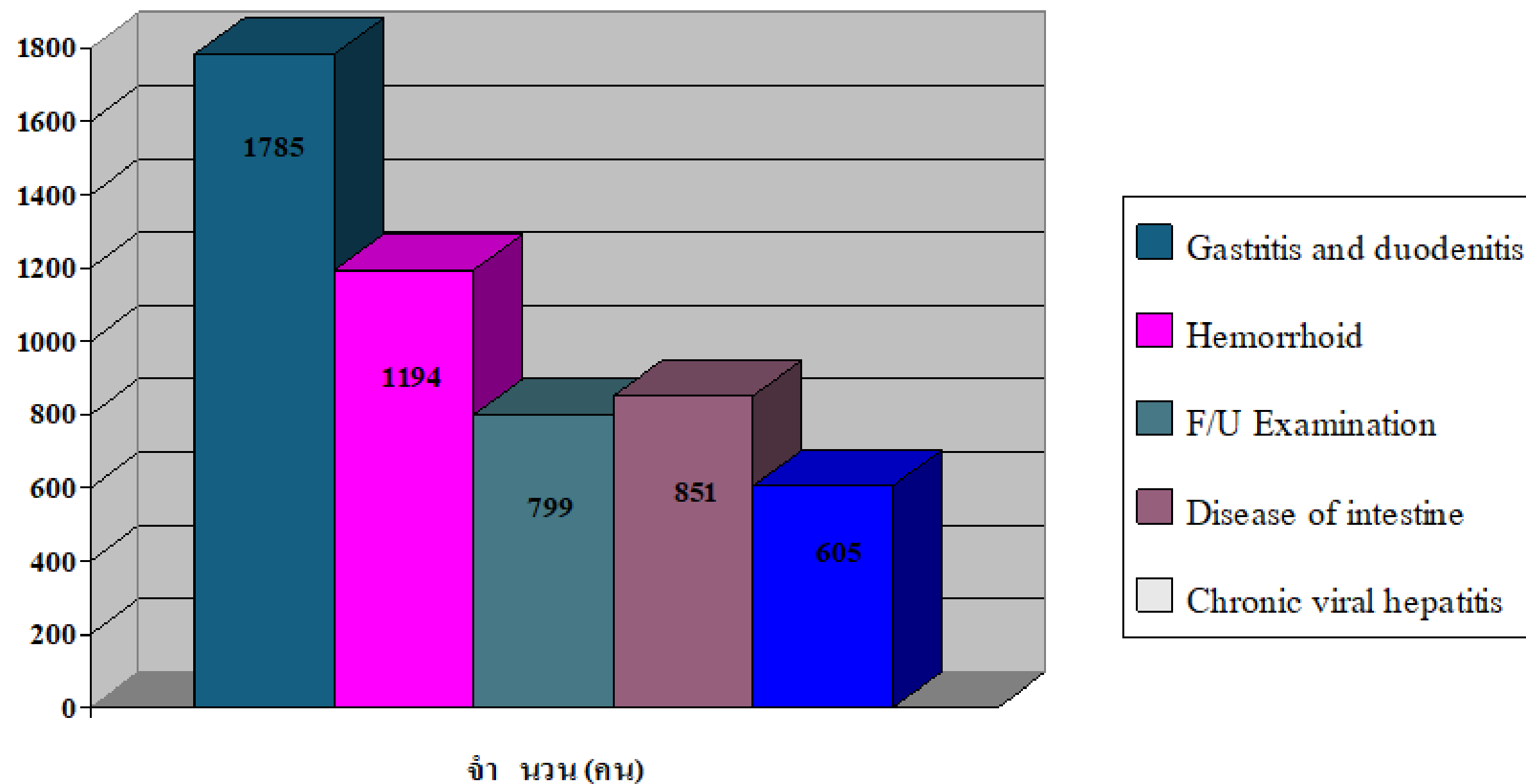
แผนกที่ปฏิบัติงาน	รายการข้อสมรรถนะ
การพยาบาลอายุรกรรม	การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การพยาบาลศัลยกรรม	การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระเพาะอาหาร
การพยาบาลห้องผ่าตัด	การดูแลผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดกระดูกสันหลัง
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

สมรรถนะการจัดการดูแลผู้ป่วย

**เป็นระดับสมรรถนะที่บูรณาการนำสมรรถนะด้านคลินิก และ
สมรรถนะเฉพาะ สู่การดูแลผู้ป่วยซึ่งอาศัยทักษะความชำนาญ
ด้านการปฏิบัติ จิตวิทยา การแก้ปัญหา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการ
ดูแลผู้ป่วย**

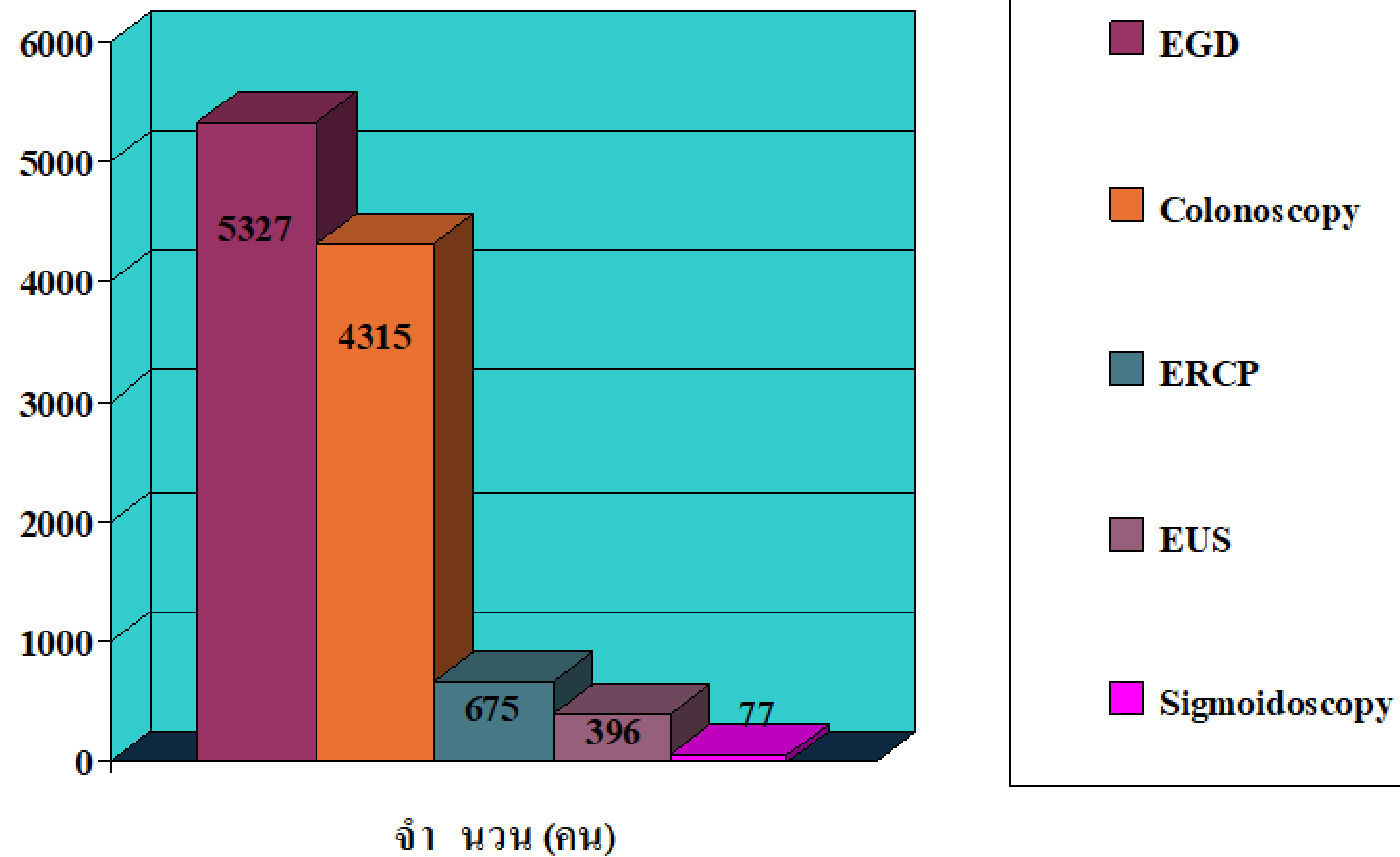
ข้อมูล/สถิติ

การกำหนด Competency



การกำหนด Competency

ข้อมูล/สถิติ



การกำหนด Competency

Job Description (JD)

ปฏิบัติการพยาบาล

- ก่อนผ่าตัด

- ระหว่างผ่าตัด

- หลังผ่าตัด



Technical Competency พยาบาลผ่าตัด



Technical Competency การพยาบาลผ่าตัด

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 หน่วยผ่าตัด

- ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลช่วยเหลือนอก
- ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด
- ความสามารถในการบริหารจัดการเครื่องมือผ่าตัด

กลุ่มที่ 2 หน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด

- การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้าห้องผ่าตัด
- การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ในห้องพักฟื้น
- การดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกที่มีภาวะวิกฤตทางระบบหายใจ
- การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มีเลือดออกผิดปกติในห้องพักฟื้น
- การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ปวดแผลในห้องพักฟื้น
- การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนจำหน่ายออกจากห้องพักฟื้น

กลุ่มที่ 3 หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ

- การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ/
หัตถการ
- การพยาบาลผู้ป่วยขณะได้รับการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ/ หัตถการ
- การพยาบาลผู้ป่วยหลังได้กับการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ/ หัตถการ
- การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการตรวจพิเศษ/
หัตถการ

การประเมิน COMPETENCY

แต่ละหน่วยงานกำหนดชนิดของหัตถการ การผ่าตัด และกิจกรรมการพยาบาลในแต่ละระดับความสามารถ

กำหนด Non technical skill ร่วมกับ Technical skill ในการประเมิน RN ทุกระดับ



ระดับความสามารถ (Proficiency Level: PL)

- **Novice** 0-1 ปี
- **Advance beginner** 1-2 ปี
- **Competent** 2-3 ปี
- **Proficient** 3-5 ปี
- **Expert** 5 ปีขึ้นไป

Benner (1984)

ระดับความสามารถ (Proficiency level : PL)	คำอธิบายความสามารถ (Key word)
1	มีความรู้และสามารถปฏิบัติการพยาบาลตามระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
2	มีความรู้เกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาที่อยู่ในขอบเขตบริการของหน่วยงาน
3	สามารถประเมินปัญหา คิดตัดสินใจจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วยตนเอง



ระดับความสามารถ (Proficiency level :PL)	คำอธิบายความสามารถ (Key word)
4	-สามารถวางแผนและให้การพยาบาลได้ครอบคลุมแบบองค์รวมและเหมาะสมกับ ผู้ป่วยแต่ละราย -สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่มีความรู้และสามารถจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ลุกล่วงไปได้ด้วยดี
5	-สามารถคาดการณ์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย -สามารถนำความรู้ใหม่มาบูรณาการใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้ -สามารถบูรณาการแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายได้



ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยขณะได้รับการ ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง

- มีความรู้และสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัดสมองและไขสันหลัง ตลอดจน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมได้



PL 1 : มีความรู้และสามารถปฏิบัติการพยาบาลตามระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้อง

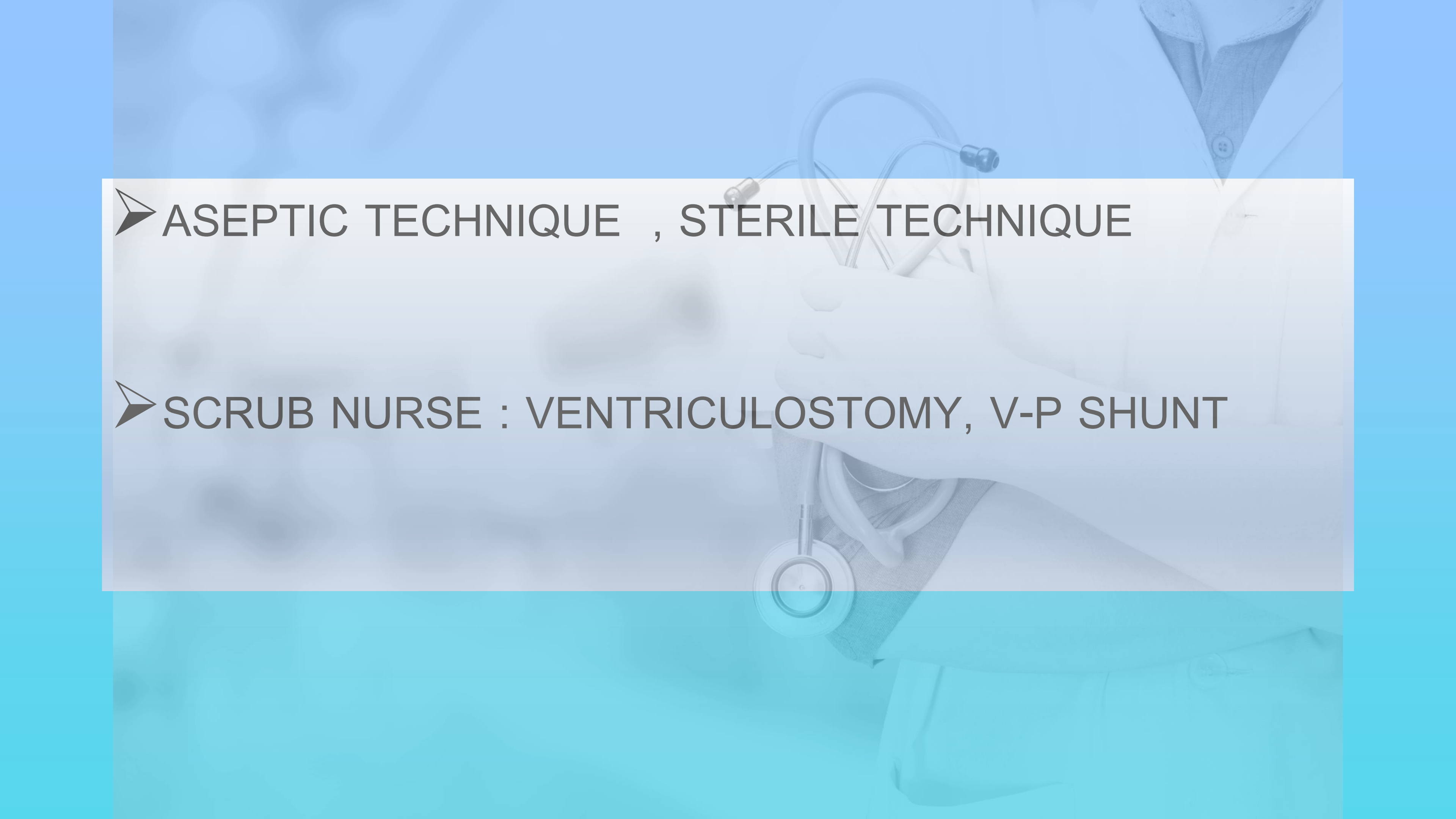
การนับผ้าซับโลहित

การนับของมีคม

การล้างมือ

การเปิดห่อของปลอดเชื้อ





➤ ASEPTIC TECHNIQUE , STERILE TECHNIQUE

➤ SCRUB NURSE : VENTRICULOSTOMY, V-P SHUNT

PL 2 : มีความรู้เกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาที่ อยู่ในขอบเขตบริการของหน่วยงาน

- โรค พยาธิสรีรภาพ อาการ การผ่าตัด
- การจัด POSITION
- ยา สารน้ำที่ใช้ในการผ่าตัด
- การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสูญเสียความร้อน
- จัดเตรียม ส่งเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานได้



PL 3 : สามารถประเมินปัญหา จิตตสันใจจัดการกับสถานการณ์ต่างๆใน การปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วยตนเอง

- สามารถแสดงบทบาทของ Circulating nurse ภายใต้การกำกับดูแลของพี่เลี้ยงได้ เช่น ประเมินปัญหา และบริหารจัดการให้มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้ในการผ่าตัด
- สามารถแสดงบทบาทของ Scrub nurse ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงได้ เช่น สามารถจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น การผ่าตัด Craniotomy tumor removal , Cerebral aneurysm

PL 4 :สามารถวางแผนและให้การพยาบาลได้ครอบคลุมแบบองค์รวม และเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
: สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่มีความรู้และสามารถจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยให้หลุดวงไป
ได้ด้วยดี

◆ Early detection

- การป้องกันภาวะฉุกเฉินหฤมิกายต่ำขณะผ่าตัด
- การเยี่ยมและให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
(Preoperative visit)
- การให้ข้อมูลกับญาติผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง

PL 5 : สามารถคาดการณ์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในการให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย

- ▶ การคาดการณ์ การวิเคราะห์ การจัดการปัญหา
- ▶ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
- ▶ ช่วยเหลือเบื้องต้นได้

PL 5 : สามารถนำความรู้ใหม่มาบูรณาการใช้ในการดูแลผู้ป่วยสามารถบูรณาการ
แผนการดูแลเพื่อบริหารจัดการผู้ป่วย แต่ละรายได้

☐ บูรณาการความรู้

☐ Case management

- Process Improvement
- CQI
- Best practice
- Innovation
- Research Utilization
- Research

โครงการวิจัย

การสังเกตพฤติกรรม Non-technical skill ของพยาบาล
ส่งเครื่องมือผ่าตัด

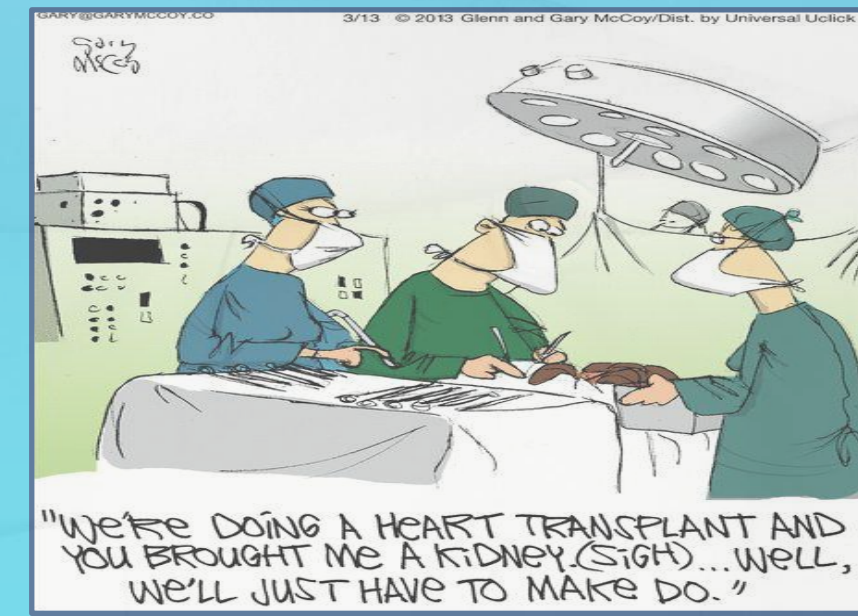


Non technical skill

- ทักษะรอบด้านของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการคิด การสื่อสาร และทักษะทางสังคมที่ใช้ร่วมกับทักษะในการปฏิบัติงาน (technical skill) เพื่อลดความผิดพลาด ทำให้เกิดความปลอดภัย และทำให้การทำงานร่วมกับทีมผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- Non-technical skill นี้ไม่สามารถเรียนรู้ และฝึกฝนก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงได้ จึงต้องมีการอบรมพยาบาลให้มีความรู้และฝึกทักษะเหล่านี้หลังจากที่มีประสบการณ์การทำงานในห้องผ่าตัดแล้ว

Non-technical skill for surgical team

The Anesthetists' Non-Technical Skill System (ANTS)	Non-technical skills for surgeons (NOTSS)	Scrub practitioners' intraoperative non-technical skill (SPINTS)
1) Task Management	1) Situation Awareness	1) Situation Awareness
2) Team Working	2) Decision Making	2) Communication and Teamwork
3) Situation Awareness	3) Communication and Teamwork	3) Task Management
4) Decision Making	4) Leadership	



Scrub practitioners' intraoperative non-technical skill (SPINTS)

- 1) การตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา (Situation awareness)
 - 1.1) การรับรู้ข้อมูล (Gathering information)
 - 1.2) ยอมรับ และทำความเข้าใจกับข้อมูล (Recognizing and understanding information)
 - 1.3) การคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต (Anticipating)
- 2) การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม (Communication and teamwork)
 - 2.1) การสื่อสารเพื่อยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง (Acting assertively)
 - 2.2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchanging information)
 - 2.3) การร่วมงานกับผู้อื่น (Coordinating with others)
- 3) การบริหารจัดการงานที่สำคัญ (task management)
 - 3.1) การวางแผนและเตรียมการ (Planning and preparing)
 - 3.2) การปฏิบัติตาม และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Providing and maintaining standards)
 - 3.3) การเผชิญกับภาวะกดดัน (Coping with pressure)

ตัวอย่างการประเมิน Non Technical skill ใน Specific Functional Competency



Specific Functional Competency

2.ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลใน บทบาทของพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด
คำจำกัดความ: การมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด

ระดับ ความสามารถ	พฤติกรรมบ่งชี้
Level 1	1.สามารถปฏิบัติตาม WI เช่น การนับผ้าซับโลहित การนับสิ่งมีคม ที่ใช้ในการผ่าตัด เป็นต้น 2.สามารถปฏิบัติตามหลัก Aseptic technique & Sterile technique ได้ เช่น การล้างมือ ใส่เสื้อ ใส่ถุงมือ เพื่อการผ่าตัด 3.สามารถตอบคำถามในกระบวนการ surgical safety checklist ได้ 4.สามารถแสดงบทบาทของพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด(Scrub nurse) ในการผ่าตัดพื้นฐาน ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงได้ 5.สามารถจัดเตรียมและส่งเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงได้ 6. ปกป้องบริเวณเขตปลอดเชื้อและเครื่องมือปลอดเชื้อตลอดการผ่าตัด 7. ดูการผ่าตัดอย่างตั้งใจ 8. เก็บข้อมูลจากทีมผ่าตัด โดยการฟังอย่างตั้งใจ
Level 2	1.สามารถอธิบายพยาธิสรีรภาพ อาการ และวิธีการผ่าตัดขั้นพื้นฐานได้ 2.สามารถเตรียมยาและสารน้ำที่ใช้ในการผ่าตัด ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงได้ 3.สามารถจัดเตรียมและส่งเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานได้ 4. ให้ข้อมูลที่ชัดเจน กระชับได้ใจความกับทีมผ่าตัด เช่น การส่งของมีคม, การ confirm specimen เป็นต้น 5. ควบคุมอารมณ์ไม่ขึ้นเสียง หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพใส่ผู้ที่อารมณ์เสีย

Specific Functional Competency

ระดับ ความสา มารถ	พฤติกรรมบ่งชี้
Level 3	1.สามารถอธิบายพยาธิสรีรภาพ อาการ และวิธีการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ 2.สามารถเตรียมยาและสารน้ำที่ใช้ในการผ่าตัดได้ 3.สามารถจัดเตรียมและส่งเครื่องมือผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อน ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงได้ 4.แสดงความต้องการในจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับงานที่ทำ 5.สามารถปรับเปลี่ยนลำดับของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Level 4	1.สามารถเตรียมยาและสารน้ำที่มีความเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่ใช้ในการผ่าตัดได้ 2.สามารถจัดเตรียมและส่งเครื่องมือผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ 3.สามารถแสดงบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงเพื่อควบคุมดูแลพยาบาลรุ่นน้องในการส่งผ่าตัดได้ 4.สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตขณะผ่าตัดได้ เช่น ภาวะ Bleeding 5.วางแผนและเตรียมงานที่ดี 6.แนะนำทางเลือก/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์กับทีมผ่าตัด
Level 5	1.สามารถคาดการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เช่น การแนะนำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือขณะผ่าตัดได้ (คาดการณ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของการผ่าตัด) 2.สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัด สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เช่น การนำหลักฐานเชิงประจักษ์ และผลงานวิจัยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัดได้ เป็นต้น 3.สามารถร่วมทำหรือทำวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้ 4.สามารถเป็นที่ปรึกษาและนิเทศงานเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยขณะผ่าตัด 5.มอบหมายงานให้ผู้อื่นที่สามารถทำได้ เพื่อลดแรงกดดันในสถานการณ์ที่มีความกดดัน 6.แสดงออกถึงภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ (ให้ข้อมูลกับทีมผ่าตัด, รับฟังผู้อื่น, ควบคุมอารมณ์)

1.ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลช่วยเหลือรอบนอก

คำจำกัดความ: การมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาลในการช่วยเหลือรอบนอก

ระดับ ความสาม ารถ	พฤติกรรมบ่งชี้
Level 1	1.สามารถปฏิบัติตาม WI เช่น การทำความสะอาดห้องผ่าตัด , การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานในห้องผ่าตัด ได้แก่ เตียง , suction , การนับผ้าซับโลहित , การนับเครื่องมือ , การนับสิ่งมีคม 2.สามารถปฏิบัติตามหลัก Aseptic technique & Sterile technique ได้ เช่น การเปิดห่อของปลอดเชื้อ , ช่วยใส่เสื้อให้แพทย์ 3.สามารถอธิบายและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำผู้ป่วยชั้นพื้นฐานได้ 4. ติดตาม สังเกตขั้นตอนการผ่าตัดอย่างจริงจัง 5. สื่อสารกับพยาบาลรุ่นพี่/ ทีมผ่าตัดทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 6. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่จำเป็นครบถ้วนด้วยลายมือที่อ่านง่าย
Level 2	1.สามารถอธิบายพยาธิสรีรภาพ อาการ และวิธีการผ่าตัดชั้นพื้นฐานได้ 2.สามารถช่วยแพทย์ในการจัดทำผ่าตัด ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงได้ 3.ให้การพยาบาลผู้ป่วยขณะผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้น เช่น Hypothermia , อันตรายจากการใช้น้ำยาหรือสารเคมีต่างๆ , การ Burn จากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า 4.สามารถทำ Surgical safety checklist ได้ 5. แจ้งทีมแพทย์ทันที เมื่อพบว่าผู้ป่วยเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่ปลอดภัย 6. แสดงออกอย่างเหมาะสม/ ควบคุมอารมณ์เมื่อถูกตำหนิ โดยไม่ให้กระทบงานที่ทำอยู่ 7. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่จำเป็นเพื่อการดูแลต่อเนื่องได้ครบถ้วน กระชับ ชัดเจน

ระดับ ความสาม ารถ	พฤติกรรมบ่งชี้
Level 3	1.สามารถอธิบายพยาธิสรีรภาพ อาการ และวิธีการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ 2.สามารถจัดทำในการทำผ่าตัดที่ยุ่งยากได้ 3.ให้การพยาบาลผู้ป่วยขณะผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ซับซ้อนได้ เช่น Nerve injury , Deep vein thrombosis 4.สามารถติดต่อประสานงานและส่งต่อข้อมูลภายในหน่วยงานได้ 5.สามารถควบคุมดูแลให้พยาบาลรุ่นน้อง ส่งผ่าตัดในการทำผ่าตัดพื้นฐานได้ 6.สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้ยา Antibioticตามแผนการรักษา 7. จัดลำดับความสำคัญของงาน โดยคำนึงเรื่องความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นสำคัญ 8. เตรียมห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัดให้พร้อมเมื่อทราบว่าจะมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน
Level 4	1.สามารถจัดทำในการทำผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ 2.สามารถคาดการณ์และวางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วยขณะผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ซับซ้อนได้ 3.สามารถติดต่อประสานงานและส่งต่อข้อมูลภายนอกหน่วยงานได้ 4.สามารถควบคุมกำกับดูแลให้พยาบาลรุ่นน้อง ส่งผ่าตัดในการทำผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ 5.สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตามแผนการรักษาที่ยุ่งยากอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารยา High Alert Drug 6. ให้ความช่วยเหลือทีมศัลยแพทย์ ทีมวิสัญญี เมื่อทีมเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภาวะเลือดออกมาก การใส่ท่อช่วยหายใจยาก เป็นต้น
Level 5	1.สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัด สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เช่น การนำหลักฐานเชิงประจักษ์และผลงานวิจัยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัดได้ เป็นต้น 2.สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดได้เช่น ผ่าซับซ้อนโลหิตนับไม่ครบ , เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งสิ่งส่งตรวจ ฯลฯ 3.สามารถร่วมทำหรือทำวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้ 4.สามารถเป็นที่ปรึกษาและนิเทศงานเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยขณะผ่าตัด 5. ให้คำแนะนำแพทย์ เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่คาดว่าจะอันตรายต่อผู้ป่วย 6. เสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา/ จัดการเหตุการณ์ต่างๆ เชิงระบบอย่างสร้างสรรค์

ORIGINAL RESEARCH:
EMPIRICAL RESEARCH – QUALITATIVE

WILEY

JAN
Leading Global Nursing Research

Nontechnical skills of the operating theatre circulating nurse: An ethnographic study

Ilaria Redaelli 

Perioperative Care and Operating Room Management 23 (2021) 100167



Contents lists available at ScienceDirect

Perioperative Care and Operating Room Management

journal homepage: www.elsevier.com/locate/pcom

Development and psychometric evaluation of a behavioral marker system for circulating nurse's non-technical skills

Reza Kalantari ^a, Zahra Zamanian ^{a,*}, Mehdi Hasanshahi ^b, Jamshid Jamali ^c, Ali Akbar Faghihi ^d,
Hadi Niakan ^e, Javad Abbasi ^f

4) การตัดสินใจ และภาวะผู้นำ (decision making and leadership)

4.1) การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและการจัดการ (Prioritization)

4.2) จูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (Negotiation)

4.3) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuing learning)

Non technical skills in Perioperative Nurses

1) การตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา (Situation awareness)

- 1.1. การรับรู้ข้อมูล (Gathering information)
- 1.2. ยอมรับ และทำความเข้าใจกับข้อมูล (Recognizing and understanding information)
- 1.3. การคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต (Anticipating)

2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานเป็นทีม (Effective Communication and Teamwork)

- 2.1. การสื่อสารเพื่อยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง (Acting assertively)
- 2.2. การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchanging information)
- 2.3. การร่วมงานกับผู้อื่น (Coordinating with others)

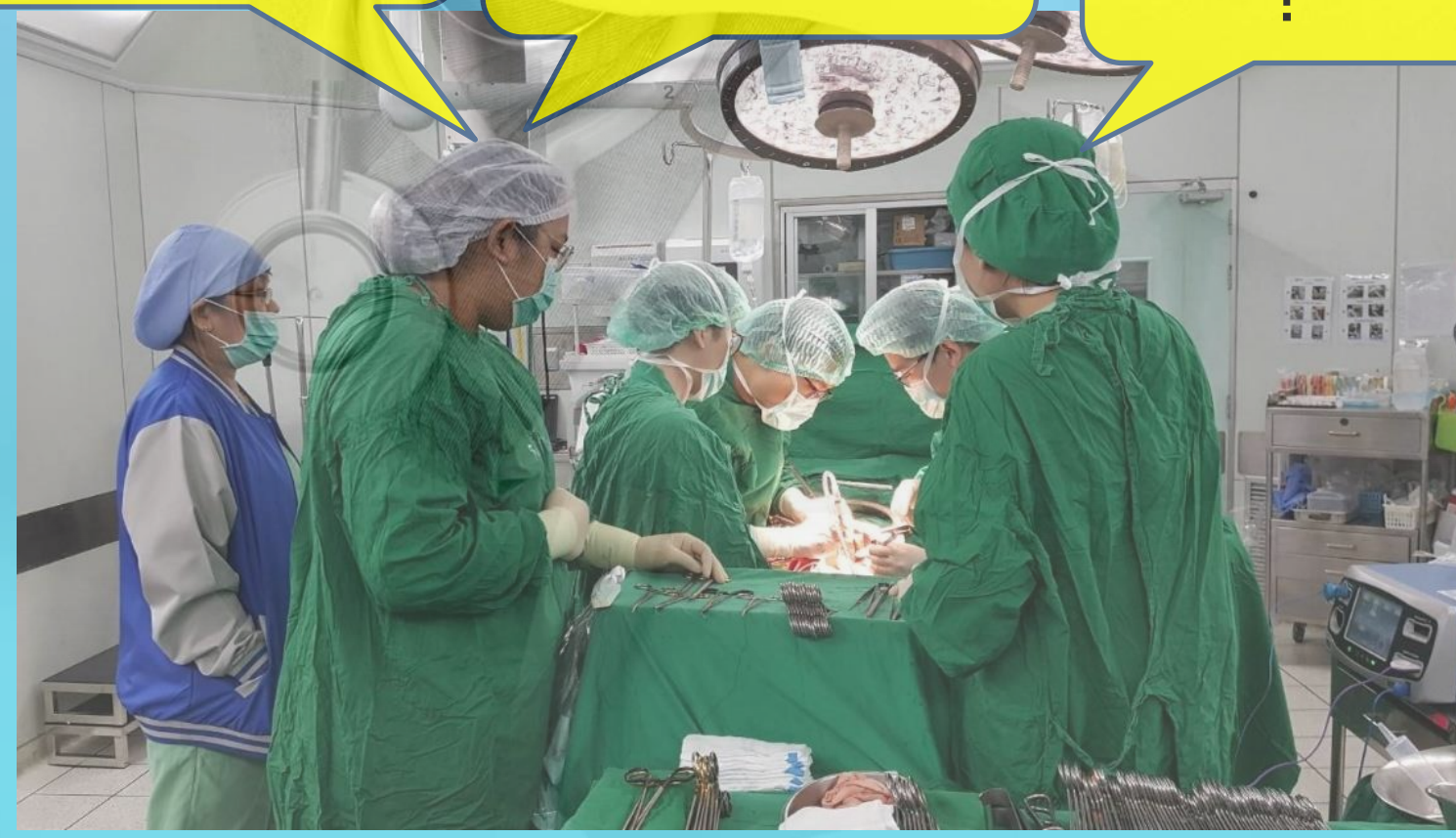
3) การบริหารจัดการงานที่สำคัญ (task management)

- 3.1. การวางแผนและเตรียมการ (Planning and preparing)
- 3.2. การปฏิบัติตาม และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Providing and maintaining standards)
- 3.3. การเผชิญกับภาวะกดดัน (Coping with pressure)

4) การตัดสินใจ และภาวะผู้นำ (decision making and leadership)

- 4.1) การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและการจัดการ (Prioritization)
- 4.2) จูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (Negotiation)
- 4.3) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuing learning)

FC02	การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
ความหมาย	วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รวมทั้งข้อมูลต่างๆเพื่อกำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์
Competency Description	
ระดับ	ตัวชี้วัดพฤติกรรม(Behavior Indicator)
1 (*รวบรวมข้อมูลและ แก้ไขปัญหาตาม แนวทางที่กำหนดได้)	- ประเมินสถานการณ์ รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวัน - ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและติดตามผลได้ตามแนวทางที่กำหนด
2 (*ลำดับความสำคัญ ของปัญหา และแก้ไข ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้)	แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ - กำหนดลำดับความสำคัญของประเด็น/ปัญหา - วิเคราะห์ กำหนดแนวทางเลือก วางแผนปฏิบัติการ (Action plan) แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนและติดตามประเมินผล
3 (*วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาที่ซับซ้อนได้ *เป็นที่ปรึกษาได้)	แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ - วิเคราะห์สถานการณ์ภายในหน่วยงาน กำหนดแนวทางเลือก วางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อป้องกันความเสี่ยง - ตัดสินใจแก้ไขปัญหาดังกล่าวในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและติดตามประเมินผลได้ - เป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
4 (*คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ)	แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ - คาดการณ์ แนวโน้มของสถานการณ์ที่ซับซ้อน กำหนดแนวทางเลือก และแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อป้องกันปัญหาที่มีความเสี่ยงสูง - ตัดสินใจแก้ปัญหาดังกล่าว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของทุกฝ่าย (Win-win situation) - สอนและแนะนำ (Coaching) การแก้ไขปัญหากับผู้ร่วมงานได้



การประเมิน **Competency**

- **Audit**
- **Certification / Training**
- **Quality Improvement (CQI)
Process Improvement (PI)**
- **Interview**
- **Observation**
- **Testing**

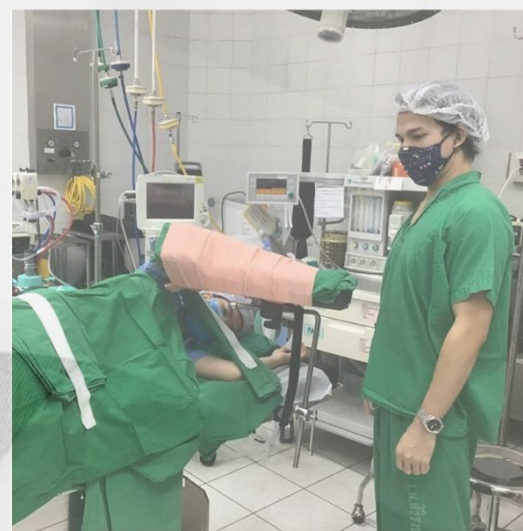
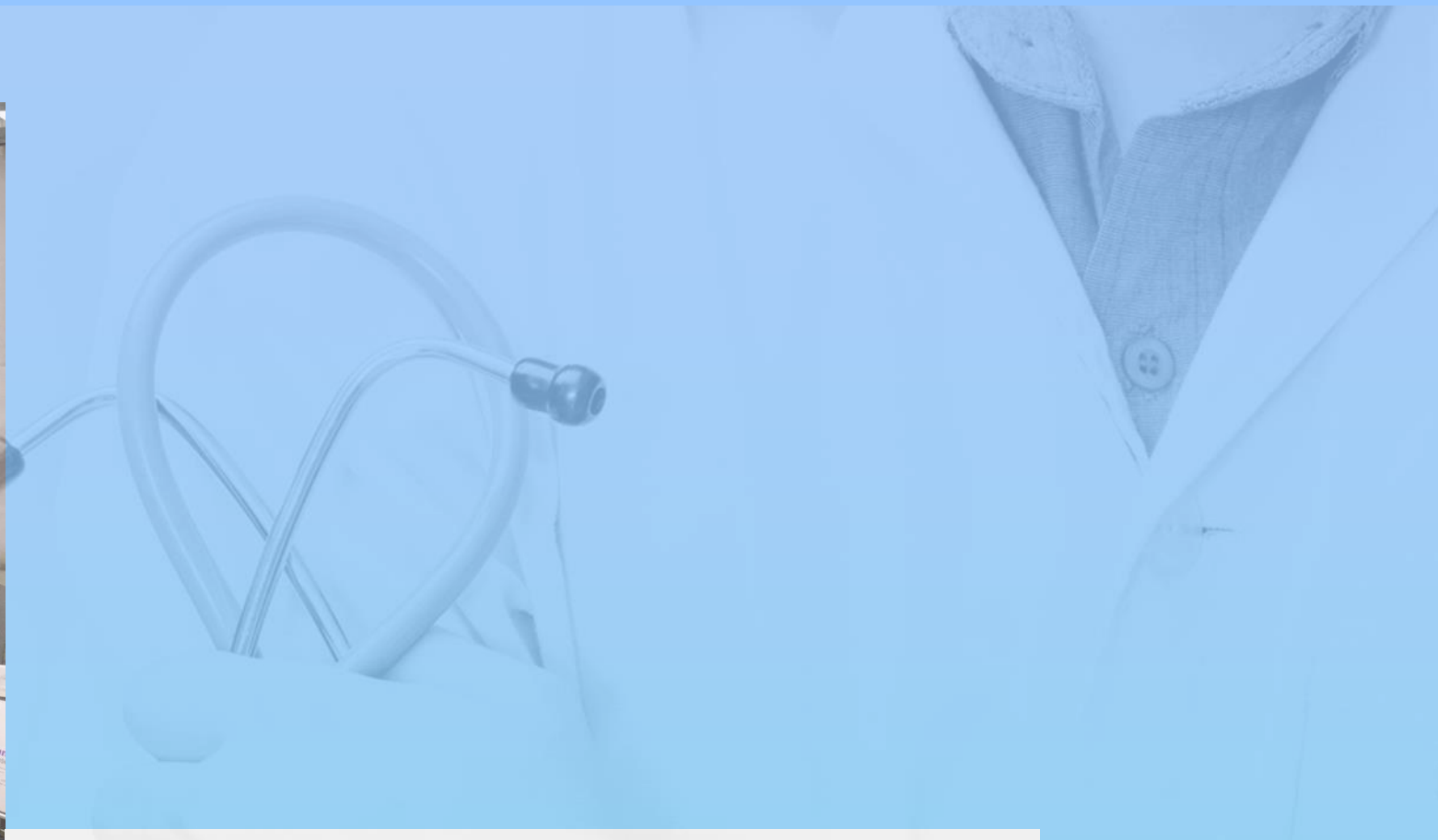
เลือกเครื่องมือ

- แบบวัดความรู้
 - สอบความรู้ (ข้อสอบ)
- แบบวัดทัศนคติ
- แบบวัดการปฏิบัติ



การสอบวัดความรู้





การประเมินCompetency

- ประเมินความสามารถของพยาบาลปีละ **1** ครั้ง
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
สูงอยู่เสมอ

การกำหนดแผนการพัฒนา

- ผู้รับการประเมินกำหนดเอง
- ผู้บังคับบัญชากำหนดโดยพิจารณาจาก
ความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงาน
ความเร่งด่วนของปัญหา ตาม Schedule ที่มีการจัด
อบรม

เกณฑ์ประเมินระดับสมรรถนะ: 1 = novice 2 = beginner 3 = competent 4 = proficient 5 = expert
E = expect (ความคาดหวังของหน่วยงาน) S = self assess (ประเมินตนเอง) P = preceptor assess (assessor ประเมิน) G = gap (ความต่าง, ช่องว่าง)

หัตถการรวมบัญชี PROCEDURES	ระดับสมรรถนะที่ ประเมิน			
	E	S	P	G
8. Pericardectomy				
9. Pneumonectomy/ Lobectomy				
10. Rib resection				
11. Thoracoplasty				
12. Tracheal resection				
13. Transthoracic diaphragmatic herniorrhaphy				
14. Vain Harvesting				
a) Endoscopic				
b) Open				
GENERAL SURGERY				
1. Abdominal perineal resection				
2. Adrenalectomy				
3. Anal fissurectomy				
4. Appendectomy				
5. Breast biopsy				
6. Central Line Insertion				
a) Hickman				
b) Groshong				
c) Port -A cath				
7. Cholecystectomy/ cholangiogram				
8. Colectomy				
9. Colon resection				
10. Colostomy/ileostomy				
11. Gastrectomy				
12. Gastroplasty				
13. Hemorrhoidectomy				
14. Hepatic resection				
15. Herniorrhaphy				
a) Inguinal				
b) Umbilical				
16. Hiatal herniorrhaphy				
a) Transabdominal				
b) Transthoracic				
17. Hydrocelectomy				
18. Imperforate anus reconstruction				

แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล	☐ สมรรถนะด้านความปลอดภัย	☐ CARDIOTHORACIC	☐ ORAL SURGERY	☐ TRAUMATIC SURGERY
ตำแหน่ง	☐ สมรรถนะด้านการตอบสนองทางกาย	☐ GENERAL SURG.	☐ ORTHOPEDICS	☐ UROLOGY
ประสบการณ์	☐ สมรรถนะด้านการตอบสนองพฤติกรรม	☐ GYNECOLOGY	☐ OTORHINOLARYNGO	☐ VASCULAR SURGERY
ว.ค.ป. ที่ประเมิน	☐ สมรรถนะด้านระบบสุขภาพ	☐ NEUROSURGERY	☐ PLASTIC	☐ OTHER SKILLS
☐ Age Appropriate NS Care	☐ ENDOSCOPY	☐ OPHTHALMOLOGY	☐ TRANSPLANTATION	☐ EQUIP & SUPPLIES

เกณฑ์ประเมินระดับสมรรถนะ 1 = novice 2 = beginner 3 = competent 4 = proficient 5 = expert

E = expect (ความคาดหวังของหน่วยงาน) S = self assess (ประเมินตนเอง) P = preceptor assess (assessor ประเมิน) G = gap (ความต่าง, ช่องว่าง)

พฤติกรรมบ่งชี้ perioperative nursing care	ระดับสมรรถนะที่ประเมิน			
	E	S	P	G
สมรรถนะการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย				
1. การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากสารเคมี				
2. การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากเครื่องใช้ไฟฟ้า				
3. การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากรังสี				
4. การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากการเคลื่อนย้าย				
5. การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากการจัดทำ				
6. การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากเลเซอร์				
7. การป้องกันอันตรายจากการใช้ Tourniquet				
8. การป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม/ อุปกรณ์				
9. การป้องกันอันตรายจากสาเหตุอื่นๆ				
9.1 การป้องกันอันตรายจากการใช้ยา				
9.2 การส่งสิ่งส่งตรวจ				
9.3 การป้องกันการผ่าตัดผิดพลาด				
9.4 การป้องกันสิ่งตกค้างในร่างกายผู้ป่วย				
สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยด้านร่างกาย				
1. การป้องกันการติดเชื้อ				
1.1 การปฏิบัติการพยาบาลด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ				
1.2 การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วย				
1.3 การจำแนกแผลผ่าตัดได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล				
1.4 การเตรียมความสะอาดผิวหนังบริเวณผ่าตัด				
1.5 การป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค				
1.6 การวางแผนเพื่อลดระยะเวลาในการผ่าตัด				
1.7 การทวนสอบการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด				
1.8 การสอนและกระตุ้นผู้ป่วย เกี่ยวกับ การไอ หายใจลึก และการออกกำลังกาย				
1.9 การดูแลแผลผ่าตัด				
2. การดูแลการกัมขาบของเนื้อเยื่อ				
3. การดูแลอุณหภูมิกาย				
4. การดูแลภาวะสมดุลของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และกรดด่าง				
5. การดูแลการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด				

พฤติกรรมบ่งชี้ perioperative nursing care	ระดับสมรรถนะที่ประเมิน			
	E	S	P	G
6. การจัดการความปวด				
สมรรถนะการพยาบาลเพื่อตอบสนองผู้ป่วยด้านพฤติกรรม				
1. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ				
1.1 การประเมินความสามารถในการสื่อสารของผู้ป่วย				
1.2 การประเมินระดับความรู้ของผู้ป่วย				
1.3 การประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้ป่วย				
1.4 การให้ความรู้/คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติตามความต้องการ				
1.5 การประเมินสภาวะด้านจิตสังคม				
1.6 การดูแลด้านจิตใจผู้ป่วย				
1.7 การให้คำแนะนำปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยในห้องผ่าตัด				
1.8 การให้ความรู้ด้านโภชนาการ				
1.9 การให้ความรู้ด้านการบริหารยา				
1.10 การให้ความรู้ด้านการจัดการความปวด				
1.11 การให้ความรู้เรื่องการดูแลแผลผ่าตัด				
2. จริยธรรมและการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย				
2.1 การตรวจสอบการยินยอมผ่าตัด				
1) กรณีผู้ป่วยยินยอมผ่าตัด				
2) กรณีผู้ป่วยไม่ยินยอมผ่าตัด				
3) กรณีผู้ป่วยยังไม่เห็นใจยินยอมการผ่าตัด				
4) กรณีผู้ป่วยอยู่ในภาวะไร้ความสามารถ				
2.2 การให้ความสำคัญกับคุณค่าและความต้องการของผู้ป่วย				
2.3 การวางแผนให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วม				
2.4 การให้ข้อมูลและอธิบายแนวปฏิบัติตามความต้องการของผู้ป่วย				
2.5 การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ				
2.6 การรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย				
2.7 การปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยยึดหลักจริยธรรม และมาตรฐานตามกฎหมาย				
2.8 การดูแลอย่างเสมอภาค ปราศจากอคติ และเหมาะสมตามสถานการณ์				

Training & Development

- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด
- โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ
- Residency Training Program

การพัฒนา Technical skill



THANK YOU

